TEMA 52 · Cuidados de enfermería en pacientes postquirúrgicos

Resumen OPE Enfermería SMS · Fases del postoperatorio, URPA, ERAS/RICA, Aldrete y Bromage, posiciones, drenajes (Penrose, Kehr, Redón, Jackson-Pratt, sumidero), drenaje torácico, cicatrización, cierre de heridas, TIME, REEDA, terapia de presión negativa, abscesos, CMA y PADSS, cirugía menor, retirada de puntos, informe de continuidad, gestora de casos y Zarit

1. Postoperatorio: fases y vigilancia

Fase	Dónde	Objetivos
Inmediato (primeras 24 h)	**URPA** o UCI	ABCDE, vía aérea, hemodinámica, conciencia (**Aldrete/Bromage**), dolor, temperatura
Mediato	Planta	Tolerancia oral, **movilización precoz**, drenajes, prevención de TVP, curas
Tardío	Domicilio y primaria	Informe de continuidad de cuidados, retirada de puntos, educación y autocuidado

- En la URPA: **vía aérea** (depresión respiratoria por opioides, relajación residual), **shock hipovolémico** (taquicardia, hipotensión, palidez, frialdad, oliguria), **delirio** en ancianos, **hipotermia < 36 °C** (mantas de aire caliente), apósitos, drenajes, vías y diuresis.
- **Recuperación intensificada (ERAS / vía RICA)**:
- **Ayuno corto**: líquidos claros hasta **2 h** antes y sólidos hasta **6 h**, con bebida de carbohidratos.
- **Analgesia multimodal** ahorradora de opioides (técnicas regionales, paracetamol, AINE) para evitar íleo, NVPO y sedación.
- **Tolerancia oral precoz, sin esperar a los ruidos intestinales**.
- **Movilización el mismo día (día 0)**.
- **Sin SNG de rutina**; retirar pronto sondas y drenajes.
- **Educación preoperatoria**: la ansiedad aumenta el cortisol y el catabolismo.
- **Escala de Aldrete** (anestesia general): **actividad, respiración, circulación (PA), conciencia y coloración/SpO_2**, cada uno 0-2 (total 0-10); **alta de la URPA con ≥ 9**.
- **Escala de Bromage** (anestesia **raquídea o epidural**): bloqueo motor de las piernas: **0** eleva la pierna extendida (sin bloqueo) · 1 flexiona rodillas · 2 solo mueve pies · **3 bloqueo completo**. Para movilizar o dar el alta: **grado 0**.

Posición postoperatoria	Indicación
Decúbito supino (sin almohada)	Tras **anestesia raquídea** (prevenir la cefalea pospunción), abdomen, extremidades
Lateral / PLS	**Bajo nivel de conciencia** (evita la broncoaspiración)
Prono	Cirugía de columna o perianal
Fowler / semi-Fowler (45° / 30°)	**Tiroidectomía**, cabeza y cuello, tórax, abdomen alto (menos edema, mejor ventilación)
Trendelenburg	**Shock hipovolémico** o síncope; contraindicado en HTIC y EAP
Antitrendelenburg	Reflujo, cirugía cervical, isquemia de las piernas
Roser (cuello en hiperextensión)	Traqueotomía, tiroides
Kraske / navaja	Cirugía sacra y proctológica (pilonidal, hemorroides)

2. Drenajes

- Ideal: inerte, **radiopaco**, flexible y que no se colapse. **Profilácticos** (evitar hematoma o seroma) o **terapéuticos** (absceso, neumotórax).
- **Pasivos por capilaridad**: **Penrose** (lámina de látex plana; se fija con un punto y un **imperdible estéril** para que no se introduzca en la cavidad; macera la piel), en cigarrillo (con gasa), Silastic.
- **Pasivos por gravedad**: la bolsa siempre **por debajo** de la inserción. **Tubo en T de Kehr** (vía biliar tras explorar el colédoco): proteger la piel de la bilis (**pasta de zinc**); vigilar el débito; antes de retirarlo (días 10-21), **colangiografía**

y **pinzamiento progresivo** (empezando en las comidas). Si al pinzar aparece **ictericia, coluria, acolia, dolor o fiebre** → **despinzar y avisar**.

- **Activos (aspirativos)**: **Redón** (alto vacío en frasco; cambiar el frasco o rehacer el vacío cuando se pierde), **Jackson-Pratt** (baja presión, bulbo en «pera» que la enfermera comprime antes de cerrar), **Saratoga** (sumidero de **doble luz**: una abierta al aire evita el **efecto ventosa**) y **Abramson** (triple luz: añade **lavado** continuo).

3. Drenaje torácico (tres cámaras)

Cámara	Función	Qué vigilar
Recolección (derecha)	Recoge el líquido	Débito y aspecto; **> 200 ml/h durante 3 h** = sangrado activo (posible toracotomía)
Sello de agua (centro, 2 cm H_2O)	**Válvula unidireccional**: impide que entre aire	**Oscilación** con la respiración = **tubo permeable** (si para de golpe: obstrucción o acodamiento; si para poco a poco: pulmón reexpandido). **Burbujeo = fuga aérea** del paciente
Control de aspiración (izquierda)	Limita la presión negativa (habitualmente **−20 cmH_2O**)	En modelos húmedos, el burbujeo aquí es **normal**: indica que la aspiración funciona

- **Siempre por debajo del tórax**, vertical; conexiones fijadas con bridas y **visibles** (sin tapar con esparadrapo). Muestras por el **puerto** con jeringa, **nunca desconectando**. «Ordeñar» los tubos solo con suavidad y según protocolo.
- **No pinzar de rutina** (ni para traslados ni para el aseo). Solo: **cambiar el sistema**, tras **instilar medicación** intrapleural, hemorragia masiva hasta llegar al quirófano y prueba previa a la **retirada (≈ 24 h)** por orden médica.
- **Nunca pinzar con fuga aérea activa** (burbujeo) → **neumotórax a tensión** (disnea, hipotensión, desviación del mediastino) y **enfisema subcutáneo** (crepitación «de nieve»).

4. Heridas y cicatrización

- Fases: **inflamatoria (días 1-4)**: hemostasia, neutrófilos y **macrófagos** (las células clave); **proliferativa (días 4-21)**: **fibroblastos**, **colágeno tipo III**, angiogénesis (granulación roja y brillante), contracción y epitelización; **maduración (día 21 a 1-2 años)**: **colágeno tipo I**; la cicatriz recupera como mucho el **80%** de la resistencia.
- **Cierre por primera intención** (bordes limpios aproximados: sutura, grapas, adhesivos); **segunda intención** (herida abierta que **granula desde el fondo**: úlceras, abscesos); **tercera intención** o primario diferido (se deja abierta unos días por infección o edema y **después se sutura**).
- **Cura en ambiente húmedo** con el esquema **TIME**: **T**ejido no viable (necrosis negra, esfacelos amarillos → **desbridamiento**: el **quirúrgico** es el más rápido; el **autolítico** con hidrogel, el más lento, selectivo e indoloro), **I**nfección (plata, cadexómero yodado, DACC), **M**oisture/humedad (**alginatos y espumas** si hay mucho exudado; **hidrogel** si está seca), **E**dge/bordes (proteger la piel perilesional; **epíbole** = borde enrollado que no avanza).
- **Escala REEDA** (0-3 cada ítem; 0 = curación óptima): **R**edness/enrojecimiento, **E**dema, **E**quimosis, **D**ischarge/exudado, **A**proximación de los bordes.
- **Terapia de presión negativa (VAC)**: esponja recortada **del tamaño exacto** de la herida (**sin tocar la piel sana**), film que sobrepase **3-5 cm**, presión habitual **−125 mmHg** continua al inicio. **Contraindicada** con **tejido necrótico** sin desbridar, **osteomielitis no tratada**, **fístulas no exploradas**, **vasos u órganos expuestos** y **cáncer** en el lecho.
- NANDA: **Deterioro de la integridad cutánea (00046)** = epidermis y dermis; **Deterioro de la integridad tisular (00044)** = planos profundos (incisión profunda, UPP III-IV). **Trastorno de la imagen corporal (00118)**: acercamiento progresivo a la herida, **expresión neutra** de la enfermera e implicación en las curas.
- **Absceso**: incisión en la zona de máxima **fluctuación** siguiendo las **líneas de Langer**; romper los tabiques; lavar (con **agua oxigenada** si el pus es **fétido**, por anaerobios); **no suturar**: **mecha** y cierre por **segunda intención**.

5. Cirugía mayor ambulatoria (CMA)

- El paciente se opera y **se va a casa el mismo día**. Selección: cirugía de duración moderada sin grandes sangrados y con dolor controlable por vía oral; **ASA I y II** (III muy controlado; **IV y V excluidos**); **criterios sociales**: vivir a

menos de 1 h del hospital, **adulto responsable las primeras 24 h**, teléfono y domicilio adecuado.

- Circuito: **área preoperatoria** (listado de verificación, ayuno, retirar prótesis, joyas y esmalte) → **URPA** (**Aldrete ≥ 9**) → **unidad de readaptación al medio** (sillones: tolerancia, deambulación, ortostatismo) → **alta con PADSS ≥ 9** (constantes, deambulación, **náuseas y vómitos**, dolor y sangrado). La **micción** es obligatoria tras **raquianestesia** o cirugía urológica o ginecológica.
- Al alta: informe de cuidados, instrucciones escritas, teléfono 24 h y **llamada a las 24 h**. **Ingreso no deseado** (objetivo < 2-3%): sobre todo por **NVPO y dolor**.

6. Cirugía menor en atención primaria

- Indicaciones: lesiones benignas (nevus, acrocordones, queratosis), lipomas, quistes, **uña encarnada**. Contraindicaciones: alergia a amidas, **coagulopatía o anticoagulación**, diabetes con microangiopatía grave y **lesión pigmentada sospechosa de melanoma** (derivar). **Consentimiento** y pieza **en formol al 10%**.
- Técnicas: **afeitado (shave)** (lesiones superficiales; segunda intención), **punch** (cilindro, lesiones < 8 mm) y **escisión en elipse** (**longitud 3:1** y eje **paralelo a las líneas de Langer**).
- **Anestesia local** (amidas): lidocaína (inicio rápido), mepivacaína, bupivacaína (larga). Dosis máxima de **lidocaína: 4,5 mg/kg sin vasoconstrictor (máx. 300 mg)** y **7 mg/kg con adrenalina**; **nunca vasoconstrictor en dedos, nariz, orejas o pene**; **aspirar antes de infiltrar**. Toxicidad: **sabor metálico, acúfenos, hormigueo peribucal** → convulsiones y colapso.

Retirada de puntos	**Días**
Cara y cuello	**4-5**
Cuero cabelludo	7-8
Tronco anterior	8-10
Espalda y brazos	10-12
Piernas y articulaciones	**10-14**

7. Alta y continuidad de cuidados

- Continuidad de la **información, la relación y la gestión**. **Informe de cuidados de enfermería al alta (ICEA)**: lo hace la enfermera de planta; describe **necesidades de cuidados y dependencia** (no el diagnóstico médico) con lenguaje **NANDA-NOC-NIC** (Gordon o Henderson) e incluye la **conciliación de la medicación**. En el SMS se escribe en **SELENE** y se ve en primaria en **Ágora**; el paciente recibe **copia en papel**.
- **Enfermera de enlace hospitalaria**: detecta al paciente complejo **durante el ingreso** y prepara el alta. **Enfermera gestora de casos comunitaria**: lo sigue en el **domicilio** y coordina recursos (pacientes crónicos complejos y con enfermedad avanzada; Barthel, Katz).
- **Escala de Zarit** (sobrecarga del cuidador, 22 ítems): **< 47 sin sobrecarga**, **47-55 leve**, **≥ 56 intensa**.

TRAMPAS DE EXAMEN

! ERAS: líquidos claros **2 h** antes; tolerancia **sin esperar ruidos**; levantarse el **día 0**; sin SNG de rutina.

! **Aldrete ≥ 9 para salir de la URPA; Bromage (raquídea) grado 0 para movilizar.**

! Raquídea → **supino sin almohada**; tiroidectomía → **Fowler**; shock → **Trendelenburg**.

! Penrose = **imperdible**; Saratoga = luz abierta contra el **efecto ventosa**; Jackson-Pratt = **pera**.

! Kehr pinzado con **coluria y acolia** → **despinzar**.

! **Torácico: sello 2 cm; oscila = permeable; burbujeo en el sello = fuga; burbujeo en la aspiración = normal.**

! **Nunca pinzar para trasladar; nunca con fuga (neumotórax a tensión); > 200 ml/h × 3 h = alarma.**

! Colágeno **III** → **I**; cicatriz máx. **80%**; tercera intención = **se sutura días después**.

! TIME: **T** tejido, **I** infección, **M** humedad, **E** bordes; autolítico = **hidrogel**.

! REEDA: **R**ojez, **E**dema, **E**quimosis, **D**renaje, **A**proximación.

! VAC **−125 mmHg**; esponja **sin tocar piel sana**; no con necrosis, osteomielitis, fístula, vasos o cáncer.

! 00046 = **cutánea** (superficial); 00044 = **tisular** (profunda).

! Absceso: **no suturar**; pus fétido → **agua oxigenada**.

! CMA: **< 1 h** del hospital, **adulto 24 h**, ASA I-II; alta con **PADSS ≥ 9**; raquídea → **debe orinar**.

! Lidocaína **4,5 mg/kg** (con adrenalina **7**); nunca adrenalina en zonas acras; **aspirar antes**.

! Elipse **3:1** y **paralela a Langer**; pieza en **formol 10%**.

! Puntos: cara **4-5 días**, piernas **10-14**.

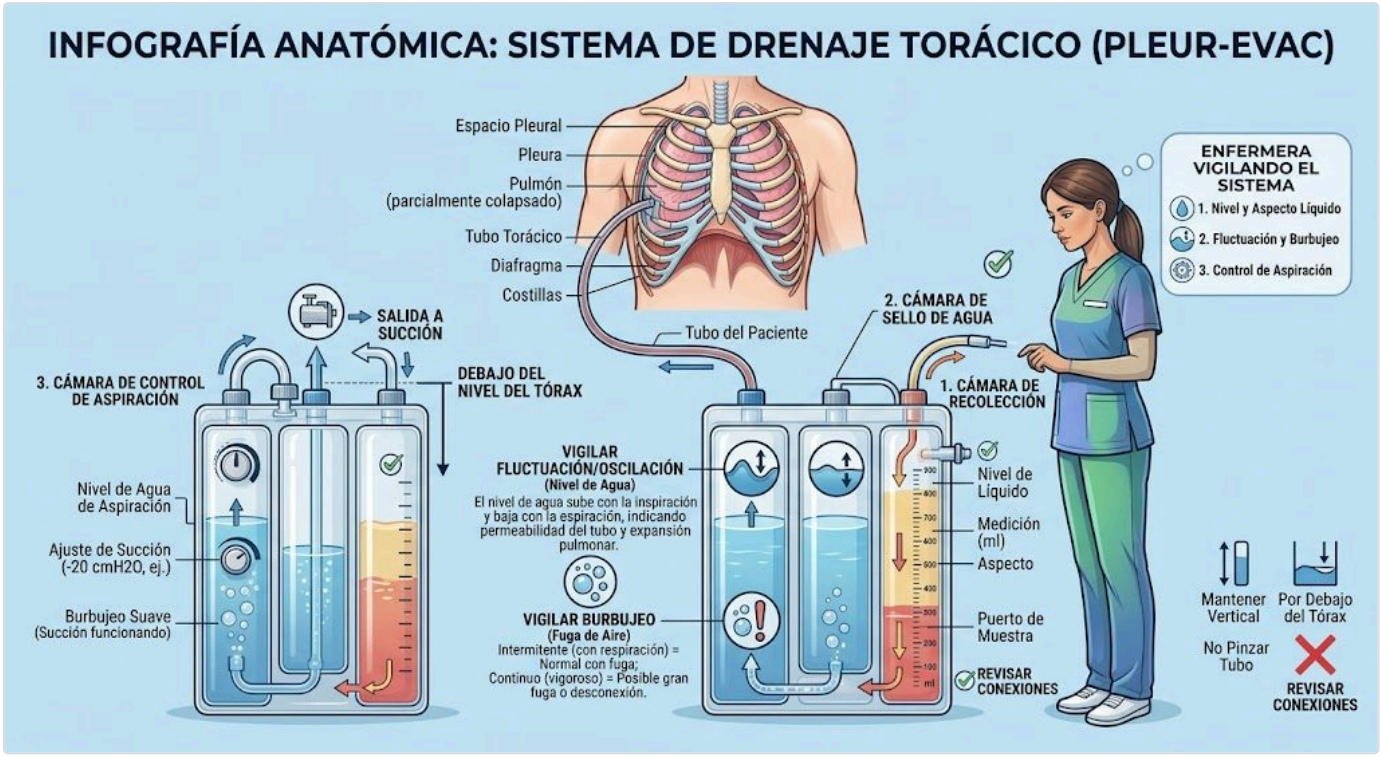
! ICEA = **cuidados**, no diagnóstico médico; enlace = **hospital**; gestora = **domicilio**.

! Zarit **≥ 56** = sobrecarga intensa.

Imágenes clave del tema



Principales posiciones anatómicas postquirúrgicas



Sistema de drenaje torácico (Pleur-evac)